

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (BSS)

Beck Scale for Suicide Ideation (Beck, Kovacs & Weissman, 1979; Beck & Steer, 1991) · Adaptación Española (Bobes et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Ideación Suicida de Beck (Beck Scale for Suicide Ideation, BSS)
Sigla / Acrónimo	BSS (o SSI en literatura anglosajona por Scale for Suicide Ideation)
Autoría original	Aaron T. Beck, Maria Kovacs & Arlene Weissman (Univ. of Pennsylvania, 1979; Beck & Steer, 1991)
Adaptación en español	Bobes García, García-Portilla, Bascarán, Sáiz et al. (2004, Banco de Instrumentos / CIBERSAM)
Constructo evaluado	Frecuencia, intensidad, letalidad, planificación y grado de intencionalidad de los pensamientos suicidas
Población diana	Adolescentes y adultos con sospecha de ideación autolítica en urgencias, psiquiatría y psicología
Tiempo de aplicación	5 a 10 minutos (mediante entrevista clínica semiestructurada o autoinforme supervisado)
Estructura y formato	21 ítems politómicos graduados de 0 a 2 puntos (19 ítems de ideación computable + 2 de intentos previos)
Condiciones de uso	Instrumento psicométrico oficial; Pearson Clinical Assessment / Uso clínico autorizado

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El fenómeno suicida no es un evento binario repentino e impredecible, sino un proceso continuo que evoluciona desde deseos pasivos de no despertar hasta la rumia autolítica activa, la planificación estructurada de métodos letales y el paso al acto. Beck y sus colaboradores diseñaron la BSS para cuantificar de forma graduada la gravedad y la intencionalidad consciente de este continuo.

A diferencia de instrumentos que solo exploran si existen pensamientos de muerte, la BSS disecciona las variables críticas de letalidad: el balance entre el deseo de vivir versus el deseo de morir, la presencia de planes específicos, el acceso a medios letales, la creencia en la eficacia del método, los preparativos finales (despedidas, testamento, notas de suicidio) y el grado de engaño u ocultación deliberada del plan frente al clínico y la familia.

3. ESTRUCTURA Y CRIBADO EN DOS FASES DE LA ESCALA BSS

Fase / Dimensión	Ítems Origen	Rango	Contenido y Operacionalización Clínica
Fase 1: Despistaje Inicial	Ítems 1 a 5	0 - 10	Deseo de vivir, deseo de morir, razones para vivir/morir, deseo activo de suicidio y evitación activa de la muerte (ítems filtro)
Fase 2: Ideación Activa	Ítems 6 a 19	0 - 28	Frecuencia, duración, actitud ante la ideación, control sobre el acto, frenos disuasorios, planificación, acceso al método, valor proyectado, preparativos y notas suicidas
Sección Suplementaria	Ítems 20 y 21	0 - 4	Número de tentativas de suicidio previas y grado de letalidad médica del intento más grave (no suman al total 0-38)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y VALIDEZ PREDICTIVA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.89 - 0.96$ en pacientes psiquiátricos ambulatorios e ingresados con tentativa de suicidio (Beck & Steer, 1991; Bobes et al., 2004).
Fiabilidad interjueces	Coefficiente de correlación intraclase CCI = $0.83 - 0.90$ en administración mediante entrevista clínica heteroadministrada estructurada.
Validez predictiva	Puntuaciones basales elevadas en la BSS multiplican por 7 el riesgo de intento autolítico en los 6 meses posteriores a una crisis afectiva.
Validez convergente	Correlación positiva muy alta con la Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS, $r = 0.82$), Escala de Desesperanza de Beck ($r = 0.68$) e Ítem 9 del BDI-II ($r = 0.74$).
Sensibilidad al cambio	Muestra un descenso rápido y clínicamente significativo tras intervenciones de estabilización en crisis, hospitalización psiquiátrica o inicio de sales de litio / clozapina.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Gradación de ítems	Cada ítem se puntúa de 0 a 2 puntos según las descripciones graduadas de menor a mayor gravedad.
Regla de salto (Gatekeeper)	Se aplican obligatoriamente los ítems 1 a 5 . Si el paciente responde 0 puntos tanto en el Ítem 4 ("Deseo de intentar suicidarse") como en el Ítem 5 ("Deseo pasivo de muerte"), se interrumpe la escala y la puntuación total se califica como 0.
Puntuación total global	Si en el Ítem 4 o en el Ítem 5 se obtiene ≥ 1 punto, se administran los ítems 6 a 19. El total es la suma de los 19 ítems . Rango teórico: 0 a 38 puntos .
Registro de intentos	Los ítems 20 y 21 son descriptivos de la historia biográfica de tentativas y se interpretan cualitativamente como factor de riesgo estático.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BSS	Percentil Aprox.	Nivel de Ideación	Significación Clínica y Nivel de Vigilancia
0 puntos	< Pc 50	Ideación Suicida Negativa	Sin ideación autolítica activa reportada en el despistaje.
1 - 6 puntos	Pc 55 - Pc 75	Ideación Suicida Leve	Deseos pasivos de muerte sin planificación ni intención activa.
7 - 19 puntos	Pc 80 - Pc 94	Ideación Moderada / Activa	Pensamientos autolíticos frecuentes; ambivalencia; exige plan de seguridad.
20 - 38 puntos	$\geq$ Pc 95	Ideación Severa / Grave	Alta intencionalidad, métodos definidos y preparativos; riesgo de rescate bajo.

PUNTOS DE CORTE Y ALERTA ROJA PSIQUIÁTRICA:

- **Cualquier puntuación > 0 :** Debe ser investigada clínicamente a fondo; no existe un "umbral seguro" de ideación autolítica.
- **BSS ≥ 15 o Positividad en Ítems 13 a 18 (Planificación/Medios/Notas):** Emergencia médica absoluta; exige derivación inmediata y custodiada a un servicio de Urgencias de Psiquiatría.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE GESTIÓN EN CRISIS AUTOLÍTICA

Paso 1: Cribado con Ítems 1 a 5: Si Ítems 4 y 5 son 0, finalizar escala y abordar factores de estrés. Si alguno es > 0, aplicar ítems 6 a 19.

Paso 2: Si BSS 1 — 6 (Ideación Leve Pasiva): Explorar factores protectores (hijos, creencias, proyectos); acordar cita de revisión en < 72 horas; facilitar teléfonos de emergencia.

Paso 3: Si BSS 7 — 19 (Ideación Moderada):

- Evaluar acceso a métodos letales en el domicilio (retirar armas de fuego y fármacos por un familiar responsable).
- Redactar Plan de Seguridad colaborativo (Stanley & Brown) y asegurar acompañamiento continuo las 24 horas por red de apoyo.

Paso 4: Si BSS ≥ 20 o Ítems 14 (Capacidad/Coraje), 15 (Expectativa de intento) o 18 (Notas escritas) = 2:

- No dejar solo al paciente bajo ninguna circunstancia.
- Traslado inmediato acompañado a Urgencias Hospitalarias para valorar indicación de ingreso psiquiátrico involuntario/voluntario.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

Identificación: Paciente mujer de 29 años, médico residente, traída por su pareja tras encontrarla acumulando blísteres de fármacos antiarrítmicos y benzodiacepinas.

Evaluación BSS:

- Fase 1: Ítem 1 (Deseo vivir) = 2 (Moderado/fuerte); Ítem 2 (Deseo morir) = 2 (Fuerte); Ítem 4 (Deseo intento) = 2 (Fuerte). Se pasa a Fase 2.
- Fase 2: Ítem 6 (Frecuencia) = 2 (Continua); Ítem 10 (Frenos disuasorios) = 2 (Ninguno); Ítem 12 (Método específico) = 2 (Completamente planeado); Ítem 13 (Acceso al método) = 2 (Fármacos en su poder); Ítem 17 (Preparativos finales) = 2 (Cuentas bancarias cerradas); Ítem 18 (Nota de despedida) = 2 (Nota escrita en su bolso).

Puntuación Total BSS = 28 / 38 (Ideación Suicida Severa con Alta Letalidad Proyectada).

Intervención Inmediata: Ingreso psiquiátrico urgente en régimen de hospitalización breve con supervisión estricta 1:1, suspensión de guardias médicas y abordaje psicofarmacológico con litio y psicoterapia DBT centrada en regulación emocional.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Letal Extremo:

- **Disimulo Activo (Ítem 16):** Pacientes decididos a morir que mienten u ocultan deliberadamente su intención para evitar que intervengan.
- **Consumo de Alcohol y Sustancias:** La desinhibición por etanol transforma instantáneamente la ideación moderada en un acto impulsivo letal.

Diagnóstico Diferencial:

- **Autolesiones No Suicidas (NSSI):** Cortes superficiales como regulación del dolor emocional sin deseo de morir (verificar intención letal real).
- **Fobias de Impulsión (TOC):** Pensamientos intrusivos y egodistónicos de hacerse daño acompañados de intenso terror y rituales de evitación.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 47(2), 343-352. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.47.2.343>
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1991). *Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation*. Psychological Corporation.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
- Brown, G. K. (2001). A review of suicide assessment measures for intervention research with adults and older adults. *National Institute of Mental Health*, 1-72.